كليــة التربية النوعية

FACULTY OF SPECIFIC EDUCATION

قسم العلوم التربوية والنفسية

رحلة فى عالم القدرات الخاصة

أعداد:- المستوى الثانى قسم تكنولوجيا التعليم(دفعة 2024/2025)

إشراف:-

دكتورة :- أمل السعيد النجار

مدرس التربيه الخاصه - كلية التربيه النوعية – جامعة بنها

رئيس قسم العلوم التربويه والنفسية	وكيل الكلية لشئون الطلاب	عميد الكلية:-
أ.م.د:- نهاد مرزوق	أ.م.د:- غادة شاكر	أ.م.د:- هانى شحتة

الفهرس

الرقم	الموضوع	الصفحة
1	الاعاقة البصرية	1-17
2	الاعاقة الذهنية	18-26
3	الاعاقة الحسية	27-31
4	الاعاقة التعليمية	31-38
5	الاعاقة السمعية	38-49

المقدمة

الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية لتحدٍ جديد يثبت فيه الإنسان قدرته على التكيف والتغلب على الصعوبات. فذوو الاحتياجات الخاصة ليسوا أقل شأنًا من غيرهم، بل يمتلكون إمكانيات وقدرات فريدة تحتاج فقط إلى الدعم والفهم الصحيح من المجتمع.

في هذا الكتاب، نسلط الضوء على أنواع الإعاقات المختلفة، بما في ذلك الحسية، الحركية، البصرية، الذهنية، والعقلية، لنقدم للقارئ فهمًا شاملًا حول طبيعة كل منها، وأسبابها، وتأثيرها على الأفراد، وكيفية توفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.

هدفنا من هذا الكتاب هو نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاحتواء والتكامل، لنؤكد أن كل فرد، بغض النظر عن حالته، له دور فعال في المجتمع يستحق الاحترام والتقدير. نأمل أن يكون هذا العمل مرجعًا مفيدًا لكل من يسعى لفهم أعمق لعالم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويساهم في بناء مجتمع أكثر إنسانية وتقبلاً للجميع.

الإعاقة البصرية

مقدمة

- الإعاقة البصرية من أكثر الإعاقات انتشارًا حول العالم، حيث تؤثر على الملايين من الأشخاص بمستويات متفاوتة من الضعف البصري إلى العمى الكلي. يمكن أن تكون هذه الإعاقة خلقية (منذ الولادة) أو مكتسبة نتيجة لحوادث أو أمراض ، تؤثر هذه الإعاقة على حياة الأفراد من عدة نواحٍ، مثل التعليم، العمل، والأنشطة اليومية، لكن مع التقدم التكنولوجي والوعي المتزايد، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية العيش باستقلالية وتحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات

تعريف الإعاقة البصرية:

- الإعاقة البصرية هي فقدان جزئي أو كلي لحاسة البصر، ف الإعاقة البصرية هى ضعف فى الرؤية لا يمكن تصحيحه باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة ، مما يؤثر على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية التي تتطلب الرؤية.
- يمكن أن تتراوح من ضعف بصري بسيط إلى العمى التام وحالة من الضعف الشديد في البصر تؤثر على قدرة الفرد على الرؤية بشكل جزئي أو كلي، مما يؤثر على أداء الأنشطة اليومية مثل القراءة والكتابة والتنقل والتفاعل الاجتماعى

تصنيفات الإعاقة البصرية وأسبابها :.

- تعددت المصطلحات الدالة على الإعاقة البصرية مثل " الأعمى ، والضرير ،
- والكفيف ، وفاقد البصر ، وضعيف البصر . حيث تتراوح الإعاقة البصرية بين العمى الكلى والجزئى .

- تُعرف الإعاقة البصرية (Visual impairment) على أنها حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية ، بما يؤثر سلبا في أدائه ونموه. بحيث يكون الشخص لديه حدة بصر تبلغ 20/200 أو أقل في العين الأقوى بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. أو لديه حقل إبصار محدود لا يزيد عن20 درجة أو لديه حدة بصر أحسن من 20/200 ولكن أقل من 20/70 في العين أقوى بعد لإجراء التصحيح اللازم. مما يحتم علي الفرد الاعتماد علي حواس أخري للتعلم وممارسة انشطة الحياة المختلفة مثل تعلم القراءة والكتابة عن طريق برايل.
- الإعاقة البصرية تعني وجود ضعف شديد في البصر أو فقدانه بالكامل، مما يؤثر على قدرة الشخص على أداء المهام اليومية التي تعتمد على الرؤية. تختلف درجات الإعاقة البصرية من شخص لآخر

- التعريف اللغوي : تستخدم ألفاظ كثيرة في اللغة العربية للتعرف بالشخص الذي فقد بصره وهذه الألفاظ هي:
- كلمة الأعمى: وهي مأخوذة من أصل مادتها وهي العماء، والعماء هو الضلالة، والعمى يقال في فقد البصر أصلا، وفقد البصر مجاز.
- وكلمة الأكمة: فمأخوذة من الكمه، والكمه هو العمى قبل الميلاد
- وكلمة الاعمه: مأخوذة من العمة، والعمة كما في لسان العرب التحير والتردد، وقيل العمة التردد في الضلالة والتحير في منازعة أو طريق . ويقال العمة في افتقاد البصر والبصيرة ، وقيل أن العمة في البصيرة كالعمى في البصر .
- وكلمة الضرير: فهي بمعنى الأعمى، لان الض ارة هي العمى ،
- وكلمة العاجز: فتطلق على المكفوف.
- وكلمة الكفيف أو المكفوف: فأصلها من الكف ومعناها المنع، والمكفوف هو الضرير وجمعها المكافيف.

تصنيفات الإعاقة البصرية

1) من حيث شدة الإعاقة:

- فئة المكفوفين Blind :- وهو الذي فقد حاسة البصر كلياً. بحيث تؤثر بشكل ملحوظ علي نموه وأدائه في مختلف جوانب حياته. ولذلك فأنه يحتاج إلي أساليب تعليمية لا تعتمد علي حاسة البصر.

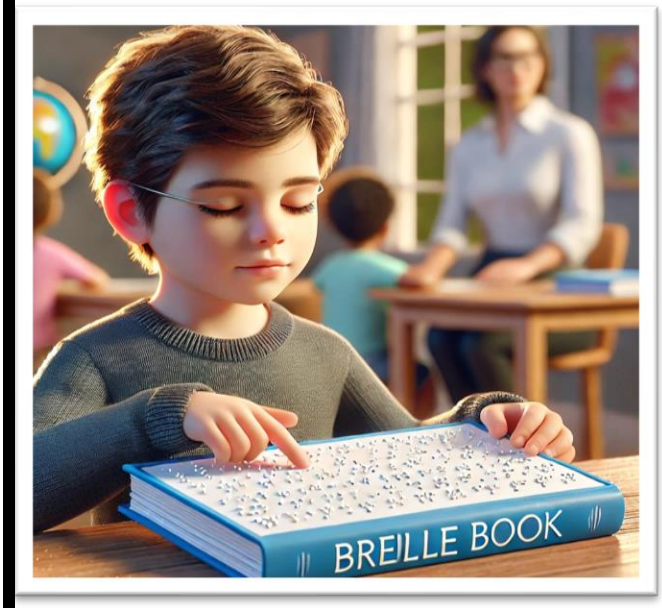
- فئة المبصرين جزئياً:Partially Sighted :-وهو الذي فقد حاسة البصر جزئياً، ويستطيع ممارسة حياته بشكل أقرب إلي الطبيعي مع تعلم القراءة والكتابة من خلال المعينات البصرية المتمثلة في النظارات الطبية أو وسائل التكبير.

2) من حيث العمر عند الأصابة:

- الإعاقة البصرية الخلقية (الولادية):- وهي تحدث مع الميلاد أو في مرحلة مبكرة من عمر الطفل قبل دخوله المدرسة ، قبل أن يتعرف الطفل علي المدركات والمفاهيم البصرية المختلفة.
- الإعاقة البصرية المكتسبة:-هي تحدث بعد سن السادسة. بعد أن يتعرف الطفل علي المدركات والمفاهيم البصرية المختلفة. بحيث يكون لديه مخزون بصري جيد وخبرات بصرية تساعده علي النمو والاداء بشكل أكثر سهولة ويسراً.

أسباب الإعاقة البصرية

- هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإعاقة البصرية، وتنقسم إلى أسباب وراثية، مرضية، بيئية، وعوامل متعلقة بالتقدم في العمر. تشمل أهم الأسباب:

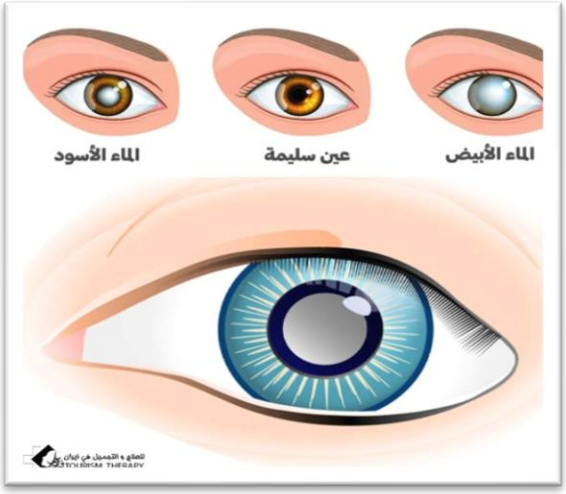


1. الأمراض الوراثية: بعض الأمراض مثل التهاب الشبكية الصباغي والمهق تؤثر على النظر منذ الولادة أو في المراحل المبكرة من الحياة.
2. الأمراض المزمنة: مرض السكري قد يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري، وهو سبب رئيسي للعمى في العديد من البلدان.
3. إصابات العين: التعرض للحوادث أو المواد الكيميائية قد يسبب تلفًا دائمًا في العين.
4. الأمراض العينية: مثل الجلوكوما (المياه الزرقاء)، وإعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، والتنكس البقعي المرتبط بالسن.
5. العدوى: بعض الفيروسات والبكتيريا يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، خاصة إذا لم يتم علاجها مبكرًا.
6. نقص التغذية: نقص فيتامين A قد يؤدي إلى العمى الليلي، وهو من أكثر أسباب ضعف البصر في الدول النامية.
7. التعرض للأشعة الضارة: مثل الأشعة فوق البنفسجية التي قد تضر بالشبكية مع مرور الوقت.
8. الشيخوخة: مع التقدم في العمر، تزداد فرص الإصابة بأمراض العيون التي قد تؤدي إلى فقدان البصر

تأثير الإعاقة البصرية على الحياة اليومية :

1. التعليم : يحتاج الطلاب ذو الإعاقة البصرية إلى مواد تعليمية بطريقة برايل أو بتنسيقات صوتية
2. التنقل : قد يعتمدون على العصالبيضاء ، أو كلاب الإرشاد ، أو أنظمة تحديد المواقع الصوتية
3. التفاعل الإجتماعى : يمكن أن تؤثر على التواصل والتكيف مع المجتمع ، لكن يمكن تخطى ذلك بالدعم والتدريب

الماء الأسود (Glaucoma)



- الماء الأسود أو الجلوكوما هو زيادة حادة في ضغط العين مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى الشبكية ويؤدي إلى تلف الخلايا العصبية وبالتالي العمى إذا لم تكتشف الحالة وتعالج مبكرًا، وتعالج الجلوكوما لدى الأطفال جراحيًا في العادة، أما لدى الكبار فهي غالبًا ما تعالج بالعقاقير، وتتدهور الحا لة البصرية.
- في هذه الحالة بالتدريج ولا تتأثر حدة البصر في البداية حيث أن البصر المحيطي هو الذي يتأثر؛ لأن التلف يحدث في الجزء الجانبي من الشبكية وينتقل تدريجيًا إلى مركز الشبكية مؤديًا إلى العمى، ومع تطور الحالة يتألم

المريض ويصبح الهدف من العلاج خفض الضغط وإيقافه أية تدهورات مزمنة، إن سبب هذه الحالة غير معروف جيدًا والمرض قد يحدث فجأة وقد يتطور تدريجيًا، وبعد سن الخامسة والثلاثين تزيد نسبة الإصابة بهذه الحالة لذا ينصح الأفراد بفحص العين بشكل دوري. هذا وتصنف المياه السوداء إلى نوعين رئيسين همها :

A. المياه السوداء الولادية : (Congenital Glaucoma)

- وتكون موجودة منذ لحظة الولادة أو بعد الولادة بقليل، وتحتاج هذه الحالة إلى جراحة مباشرة لمنع التلف، وفي الحالات الشديدة تكون القرنية مدفوعة إلى الإمام، وفي البداية يتجنب الطفل الضوء وتسيل دموعه بكثرة وهذه الأعارض تنتج عن زيادة الضغط الداخلي في العين وتلف القرنية إذ يحدث توسع فيها .

B. المياه السوداء لدى الراشدين : (Adult Glaucoma)

- يعاني الأفراد المصابون بهذه الحالة في صداع في الجزء الأمامي من الرأس خاصة في الصباح، ويمكن معالجة هذا النوع من المياه السوداء في كثير من الأحيان بقطرة العيون التي تعمل على خفض الضغط، وقد يكون كلا النوعين (الجلوكوما الولادية، وجلوكوما الراشدين) أوليًا – أي: ليس ناتجًا عن مرض ما في العيون – أو قد يكون ثانويًّا (ناتجًا عن مرض ما في العين) .[1]

الماء الأبيض(Cataract)

- هو إعتام في عدسة العين وفقدان للشفافية يؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية إذا لم تعالج الحالة، وهذا المرض يحدث عادة لدى الكبار؛ ولكنه قد يحدث مبكرًا أيضًا بسبب عوامل مثل الوراثة والحصبة

الألمانية وإصابات العين، وتسمى الحالة لدى الأطفال بالماء الأبيض الولادي (Congenital Cataract)حيث تكون القدرة على رؤية الأشياء البعيدة ورؤية الألوان محدودة، ويشكو الفرد من حساسية كبيرة للضوء أو من عدم القدرة على الرؤية جيدًا في ظروف الإضاءة القوية أو في الليل.

- ويزداد هذا المرض سوءًا تدريجيًّا ويحدث صعوبة في الرؤية، وتعتمد الأعراض على المساحة في العدسة التي حدث فيها تعتيم، وعندما تزال العدسة يصبح البصر ضعيفًا جدًّا ولا يحدث تركيز للضوء فقد تصبح حدة الإبصار 20/ 200 إلى 20/ 400 في العين إلي أجري لها عملية جراحية، ولهذا فبعد إزالة العدسة المعتمة توضع عدسة طبية خاصة، ونسبة نجاح هذه العملية تقدر بحوالي 90 – 95 %

ضمور العصب البصري : (Optic Nerve Atrophy)

- يحدث الضمور في العصب المركزي لأسباب عديدة كالأمراض التنكسية والحوادث والالتهابات والأورام ونقص الأوكسجين، وقد يحدث الضمور في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا لدى الشباب، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا المرض وراثيًّا، وتعتمد قدرات الفرد البصرية على شدة التلف فقد لا يبقى لديه بصر وقد يبقى لديه بصر جزئي.

• التليف خلف العدسي (Retrolental Fibroplasia) :

- مرض ينتج عن إعطاء الأطفال الخدج كميات كبيرة من الأكسجين مما ينتج عنه تلف في الأنسجة خلف العدسة، وتتأثر الأوعية الدموية وتتلفف الشبكية، وأحيانًاتبقى بعض الخلايا في الشبكية سليمة ولهذا يصبح لدى الفرد ما يسمى برؤية النقاط (Spot Vision) وبشكل عام، قد ينتهي هذا المرض بالعمى التام

الحول : (Strabismus)

- تتحكم عضلات العين الخارجية بحركة العيون بالاتجاهات المختلفة، ومن المهم أن تتحرك العينان معًا لدمج الخيالات البصرية لإعطاء انطباع دماغي واحد لها وهذا ما يسمى بالبصر الثنائي (Binocular Vision)
- فإذا كان هناك خلل في إحدى العضلات فلن تتحرك العينان معًا بشكل منظم وإذا ترك هذا الوضع دون تدخل علاجي فقد يستخدم الطفل عينًا واحدة وأما العين الأخرى فيصيبها كسل، وإذا استمر الوضع هكذا تضعف العين بشكل دائم، ويعتبر الحول إلى الداخل (Esotropia) وهو ما يعرف بالحول الأنسي أكثر أنواع الحول شيوعًا بين الأطفال
- وفي العادة يكون هذا الحول في عين واحدة، وفي بعض الحالات تكون كلتا العينين منحرفتين نحو الأنف، وفي حالات قليلة يكون الحول إلى الخارج (Exotropia) أو ما يعرف بالحول الوحشي ويحتاج معظم الأطفال المصابين بالحول إلى جراحة حيث أن حالات قليلة فقط يمكن معالجتها بالنظارات

خصائص الاعاقه الحسيه

1. الخصائص العقلية:

- عند تطبيق الجزء اللفظي من اختبارات الذكاء ، غالباً ما يتضح انه لا يوجد اختلاف كبير بين ذكاء المعاقين بصرياً وبين المبصرين. ومع ذلك يعاني المعاقيين بصرياً من مشكلات في مجال إدراك المفاهيم ومهارات التصنيف للموضوعات المجردة التي تتعلق بالحيز والمكان والمسافة. ولكن جانبي الانتباه والذاكرة السمعية يعدوا من العمليات العقلية التي يتفوق فيها ذوي الاعاقة البصرين علي المبصرين بسبب اعتماده بشكل كبير علي حاسة السمع.
- وفيما يخص أحتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنه لا يظهر احتياجاً كبيراً أو نقصاً شديداً لدي المعاق بصرياً عدا الحاجة إلي تبسيط وايضاح المفاهيم البصرية المجردة.

2. الخصائص الجسمية:

- لا يختلف نمو المعاقين بصرياً كثيراً عن نمو المبصرين في الجانب الجسمي من حيث الطول والوزن. كما يسير كلاهما بشكل طبيعي ، ولكن القصور يظهر في الجوانب الحركية عند المعاق بصرياً ، والتي تتمثل في القدرة علي التناسق الحركي ، والتأزر البصري الحركي ، توجيه الذات وحرية الحركة وكذلك تظهر لديهم سلوكيات نمطية ولزمات حركية. على سبيل المثال : الحركة المستمرة بالجزء العلوي من الجسم ، فرك العينين ، اللعب بالاصابع ، ضرب الركبتين ببعض.

- وفيما يخص أحتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنهم يحتاجوا إلي تدريبهم علي الانتقال في البيئة وتوفير الأنشطة الرياضية المعدلة التي تتيح للمعاقين بصرياً فرصاً أكبر للنشاط والفاعلية الحركية.

3. الخصائص اللغوية:

- تشبه لغة المعاقين بصرياً إلي حد كبير لغة المبصرين ، ولا يعانون من مشاكل واضحة في الاداء اللغوي. ولكن تختلف طريقة تعلم اللغة للمعاقين بصرياً وخاصة الأطفال عن المبصرين. فـ بينما يستطيع المبصر التعرف علي المفاهيم اللغوية وإدراكها من خلال العديد من المدخلات البصرية والسمعية مما يجعل إكتسابها أمراً يسيراً.
- إلا أن المعاق بصرياً يعتمد في طريقه تعلمه علي اسلوب فريد يحتاج فيه إلي العديد من الحواس كحاسة اللمس والشم والتذوق لدمج المعلومات وتكوين المفهوم الذي يميز شئ معين. ولصعوبة الأمر احياناً و وجدود بعض المفاهيم البصرية المجردة ، بعض المعاقين بصرياً لا يدركون بتاتاً بعض المفاهيم البصرية المرئية مثل الألوان.
- وفيما يخص أحتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنهم يحتاجوا إلي اثراء الجانب اللغوي لديهم بالوسائل والطرق المناسبة التي تعتمد علي العديد من الحواس ، وكذلك تبسيط المفاهيم البصرية المرئية التي ليس لها مدلول حسي ، سمعي أو شمي أو تذوقي ومحاولة ايضاحها للمعاقين بصرياً.

4. الخصائص الاجتماعية:

- يعاني بعض المعاقين بصرياً من مشكلات التوافق، والتي تتمثل في عزوفهم عن الانخراط في الجماعة. كما قد يشعر بأن الأخرين لا يهتمون به ، وبجانب عدم شعور المعاق بصرياً بالأمان واعتماده المعاق بصرياً علي والديه واسرته بشكل اساسي في فترات عمره المبكره وتأثير ذلك علي نموه الاجتماعي ، فأنه عندما ينتقل من بيئة الأسرة إلي مجتمع الزملاء وبيئات العمل ، يلاحظ عليه تأخراً في بعض الجوانب الأجتماعية.
- وفيما يخص احتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنهم يحتاجوا إلي إشراكهم في مواقف اجتماعية مختلفة وفي بيئات مختلفة، مما يعزز قدرتهم علي التفاعل الاجتماعي مع الأخرين.

5. الخصائص الانفعالية:

- لا يختلف النمو النفسي للمعاقين بصرياً عن دونهم من المبصريين أختلافاً كبيراً ، ولكن قد تظهر عليهم بعض المشاعر نتيجة للتحديات التي يمر بها نظراً لإعاقتهم. وتتمثل في مشاعر عدم الثقة بالنفس والدونية وعدم احترام الذات ، انخفاض مفهوم الذات ودرجة التوافق النفسي، وكذلك مشاعر القلق لعدم وضوح مستقبله المهني والاجتماعي.

- وفيما يخص أحتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنهم يحتاجوا زيادة اعتمادهم علي انفسهم وتقليل الحماية الزائدة، واشاركهم في انشطة مختلفة منذ الصغر لزيادة الثقة بالنفس، والارشاد النفسي المستمر لجعل المعاق بصرياً ينظر إلي مشكلته نظره موضوعية تبعده عن شعور النقص والدونية.

6. الخصائص الأكاديمية:

- التحصيل الأكاديمي لدي المعاق بصرياً أقل منه لدي الفرد العادي، ولكن اذا توافرت المواد التي تساعد المعاق بصرياً علي استقبال المعلومات والتعبير عنها ، قد يقترب حينها اداء الفرق المعاق بصرياً من اداء الفرد المبصر. وتظهر مشكلات التحصيل الأكاديمي لدي المعاقين بصرياً في صورة بطئ معدل القراءة واخطاء القراءة الجهرية، وصعوبة ادراك المفاهيم البصرية المرئية، وانخفاض مستوي التحصيل الدراسي.
- وفيما يخص أحتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الجانب. فأنهم يحتاجوا توفير المواد التي تساعدهم علي اكتساب المعرفة ، استقبال المعلومات المختلفة وسهولة التعبير عنها.

طرق التعامل مع الإعاقة البصرية:

- استخدام التكنولوجيا المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة وتقنيات التكبير.
- تعلم طريقة برايل لقراءة وكتابة النصوص.
- التدريب على التنقل باستخدام العصا البيضاء أو الأجهزة المساعدة.
- التأهيل المهني: تدريب الأشخاص المكفوفين على مهارات تمكنهم من العمل في مجالات مناسبة لهم.
- الدعم النفسي والاجتماعي: لمساعدتهم على التكيف مع التحديات التي تواجههم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
- الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على التكيف مع الإعاقة

تأثير الإعاقة البصرية على الحياة اليومية

- الإعاقة البصرية تؤثر على مختلف جوانب الحياة، وتشمل التأثيرات ما يلي:

- التعليم: يحتاج الطلاب ذوو الإعاقة البصرية إلى وسائل تعليمية مخصصة، مثل الكتب بطريقة برايل أو المواد الصوتية.
- العمل: يواجهون تحديات في بيئة العمل، لكن مع التكيف والتكنولوجيا يمكنهم تحقيق النجاح في مجالات عديدة.
- الحركة والتنقل: يمكن أن يكون التنقل صعبًا، لكن العصا البيضاء والكلاب المرشدة والتطبيقات الحديثة ساعدت في تحسين الاستقلالية.
- التفاعل الاجتماعي: صعوبة قراءة تعابير الوجه والإشارات قد تؤدي إلى بعض التحديات في التواصل الاجتماعي.

- المهام اليومية: مثل الطهي، التسوق، أو استخدام الأجهزة المنزلية تحتاج إلى استراتيجيات خاصة للتكيف.

دور المجتمع في دعم ذوي الإعاقة البصرية:

- توفير بيئة مهيأة تشمل لافتات برايل وإشارات صوتية في الأماكن العامة.
- تهيئة الأماكن العامة: بوضع إشارات صوتية، ولوحات بطريقة برايل في المرافق العامة.
- دمجهم في التعليم والعمل: عبر توفير مناهج مخصصة وفرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم.
- نشر الوعي: لتعزيز فهم المجتمع لاحتياجات
- الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودعمهم بشكل أكبر
- تشجيع فرص العمل والتعليم للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
- زيادة الوعي والتوعية حول احتياجات ذوي الإعاقة البصرية لتعزيز دمجهم في المجتمع ؛ الإعاقة البصرية قد تمثل تحديًا، لكنها لا تعني عدم القدرة على تحقيق النجاح والاستقلالية. بفضل التطور التكنولوجي والدعم المجتمعي، يمكن للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أن يعيشوا حياة مليئة بالإنجازات والفرص.

كيفية مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية-:

1. .توفير المساعدة: توفير المساعدة في المهام اليومية.
2. استخدام التكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا مثل البرامج النصية والبرامج الكلامية.
3. .توفير الدعم النفسي: توفير الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية.
4. .توفير الفرص التعليمية: توفير الفرص التعليمية للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية.

بعض النصائح للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية-:

- .لا تستسلم: لا تستسلم أمام التحديات، بل استمر في العمل والجهد.
- .اطلب المساعدة: اطلب المساعدة عندما تحتاجها.
- .كن إيجابيًا: كن إيجابيًا في حياتك واطمئن على أنك تستطيع تحقيق أهدافك.
- .احترم نفسك: احترم نفسك وكن فخورًا بنفسك.
- .كن صبورًا: كن صبورًا في حياتك واطمئن على أنك تستطيع تحقيق
- تشخيص الإعاقة البصرية يتطلب تحليلًا شاملاً من قبل متخصصين في مجال الرؤية والعيون. إليك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في تشخيص الإعاقة البصرية

أسس تعليم ذوي الإعاقة البصرية

- التركيز على المعلومات التي يمكنه اكتشافها واكتسابها من خلال استخدامه الحواسه والاستدلال عليها.
- تدريب حاسة اللمس عن التلاميذ المكفوفين في المراحل العمرية المبكرة.
- في حالة إدماج معاقى البصر في فصول المبصرين يجب ألا يعفي من أي نشاط.
- يجب إعطاء المعاق بصرياً أقصى فرص الاستقلالية وعدم المبالغة في مساعدتهم والاهتمام بهم.
- الاهتمام بتوفير إجراءات الأمان لهم.
- عدم الاقتصار على الشروح الشفهية.
- يجب ألا يبدأ المعلم مع التلميذ الكفيف بما هو صعب ومستحيل بل بما يمكن تحقيقه
- تنمية المهارات الأساسية للأطفال المكفوفين من خلال تطوير علاقاتهم ببعض المواد والأدوات والأجهزة العادية.
- تنمية المستوى اللغوي للتلميذ المكفوف أثناء تعامله مع أشياء معينة أو أدائه لعمليات معينة.
- يجب أن يكون معلم المكفوفين متمكناً من مهارات القراءة والكتابة بطريقة بريل، واستخدام الآلات الكاتبة والكمبيوترات التي تتعامل بطريقة بريل.
- يجب على أسرة المكفوفين أن تكون قادرة على التعامل مع أبنائهم بطريقة بريل.
- توفير المواد التعليمية التي تتناسب مع قدرات المكفوفين.
- توفير فريق العمل المؤهل والمدرب علي التعامل مع المعاق بصرياً في مختلف جوانب حياته اللغوية والنفسية والاجتماعية والمهنية.
- التكامل بين المناهج وقدرات المعاق بصرياً واحتياجات سوق العمل. بهدف ألحاقهم بالأعمال التي تتناسب مع طبيعة اعاقتهم فور انهائهم تعليمهم. حتي يستطيعوا المشاركة في المجتمع ويصبحوا افراد ذي فاعلية وتأثير مما يرفع من احساسهم بالتوافق وتقبلهم لذاتهم.
- اكتشاف مواهب المعاقين بصرياً اثناء مرحلة الدراسة والعمل علي تنميتها. فقد يتسم بعضهم بالقدرة الجيدة علي الحفظ نتيجة جودة جانبي الانتباه والذاكرة السمعية لديهم.
- تفعيل دور الأخصائي الأجتماعي والأخصائي النفسي بالمدرسية، لتوفير الارشاد والدعم النفسي المناسب الذي يساعدهم علي تحقيق المزيد من التحصيل والانجاز.
- تضمين المناهج التعليمية لمفاهيم يسهل علي المعاق بصرياً فهمها وتبسيط المفاهيم البصرية المجردة.

طرق علاج الإعاقة البصرية :

- الإعاقة البصرية تعتبر تحديًا كبيرًا يواجه الأفراد في حياتهم اليومية، ومع تقدم الطب والتكنولوجيا، ظهرت عدة طرق وأساليب لعلاج وتحسين حالة الإعاقة البصرية. إليك بحث كامل حول الطرق المستخدمة في علاج الإعاقة البصرية:

1. التشخيص المبكر

- الخطوة الأولى في علاج الإعاقة البصرية هي التشخيص المبكر. يمكن أن تشمل تقنيات الفحص البصري:

- الفحص لدى طبيب العيون. - تصوير الشبكية.

- قياس حدة البصر.

2. العدسات والنظارات

- النظارات الطبية: تستخدم لتحسين الرؤية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بسيطة مثل قصر النظر أو طول النظر.
- العدسات اللاصقة: بديل للنظارات، قد تكون مفضلة لبعض الأفراد.

3. العلاج الطبي

- الأدوية: في بعض الحالات، قد تُستخدم الأدوية لعلاج مشكلات العين مثل التهاب الشبكية.
- الجراحة: يمكن أن تكون الجراحة ضرورية لعلاج مشاكل معينة مثل إعتام عدسة العين، المياه الزرقاء.

4. التأهيل البصري

- العلاج البصري: يشمل مجموعة من التمارين التي تهدف إلى تحسين القدرات البصرية.
- البرامج التعليمية: تساعد الأفراد على التكيف مع إعاقتهم والتعلم بطرق جديدة.

5. التقنيات المساعدة

- الأجهزة البصرية: مثل المجاهر المدعومة بالتكنولوجيا، التي تساعد في تحسين الرؤية.
- التكنولوجيا المساعدة: مثل التطبيقات والأجهزة الذكية التي تصمم لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في الحياة اليومية.

6. الدعم النفسي والاجتماعي

- يلعب الدعم النفسي والاجتماعي دورًا مهمًا في مساعدة الأفراد على التكيف مع إعاقتهم. يشمل ذلك:

- مجموعات الدعم.
- تقديم المشورة.

7. البحث والتطوير

- تتواصل الأبحاث في مجال علاج الإعاقة البصرية، حيث يتم تطوير علاجات جديدة وأفضل بشكل مستمر مثل زراعة الشبكية والأدوية الخلوية.

تصنيفات الاعاقة البصرية وأسبابها:-

- تعدّدت المُصطلحات الدالّة على الإعاقة البصرية مثل: "الأعمى، الضرير، الكفيف، فاقِد البصر، ضعيف البصر"، حيث تتراوح الإعاقة البصرية بين العمى الكلّي والجزئي، وعلى هذا الأساس يوجد نوعان من الإعاقة البصرية، الأولى وهم المكفوفون "العميان" وهؤلاء تتطلّب حالهم البصرية إستخدام طريقة برايل، والثاني هم ضعاف البصر والذين يستطيعون الرؤية من خلال المُعينات البصرية المختلفة.
- الكفّ البصري التام هو مَن لا يستطيع الإبصار إطلاقاً أو الذي لا تزيد حدّة إبصاره عن 200/20 في أقوى العينين

- الإعاقة البصرية هي حال من العجز أو الضعف في حاسّة البصر تحد من قدرة الفرد على استخدام بصره "العين" بفعالية وكفاية واقتدار، الأمر الذي يؤثّر سلباً في نموّه وأدائه، وتشمل هذه الإعاقة ضعفاً أو عجزاً في الوظائف البصرية للبصر المركزي أو المحيطي تعيق الفرد كإنسان على ممارسة حياته بشكل طبيعي، والذي قد يكون ناتجاً من تشوّهٍ تشريحي أو إصابة بالأمراض أو جروح في العين، ما يؤدي إلى حاجة المصاب إلى مساعدة برامج وخدمات تربوية في مجال هذه الإعاقة لا يحتاجها الناس صحيحي البصر، ويكون ذلك تبعاً لنوع الإعاقة البصرية من حيث أنها كفّ بصري تام أو كفّ بصري جزئي.
- هذا وقد تعدّدت المُصطلحات الدالّة على الإعاقة البصرية مثل: "الأعمى، الضرير، الكفيف، فاقِد البصر، ضعيف البصر"، حيث تتراوح الإعاقة البصرية بين العمى الكلّي والجزئي، وعلى هذا الأساس يوجد نوعان من الإعاقة البصرية، الأولى وهم المكفوفون "العميان" وهؤلاء تتطلّب حالهم البصرية إستخدام طريقة برايل، والثاني هم ضعاف البصر والذين يستطيعون الرؤية من خلال المُعينات البصرية المختلفة.
- الكفّ البصري التام "الأعمى" هو مَن لا يستطيع الإبصار إطلاقاً أو الذي لا تزيد حدّة إبصاره عن 200/20 في أقوى العينين بإستخدام نظّارة طبية، كما أن درجة الإبصار تختلف من فردٍ لآخر، والتي ترتبط أيضاً بسن الكفيف ووقت الإصابة بالعجز، حيث نجد أن بعض الأفراد يولدون فاقدي البصر، وبعضهم قد فقد بصره بعد فترة زمنية معينة، الأمر الذي يجعل الثاني يحتفظ ببعض الصوَر الذهنية التي إكتسبها قبل أن يكفّ بصره بما يساعده على إدراك بعض ما يحيط به من أشياء عن طريق إستخدام حاسّة اللّمس، ولهذا تم تصنيف المكفوفين إلى أربعة أقسام على أساس درجة الإبصار هي:

- الكفّ الكلّي للبصر من الذين ولِدوا أو أصيبوا بعجزهم قبل سنّ الخامسة.
- الكفّ الكلّي للبصر من الذين أصيبوا بعجزهم بعد سنّ الخامسة.
- الكفّ الجزئي للبصر من الذين ولِدوا أو أصيبوا بهذا العجز قبل سن الخامسة.
- الكفّ الجزئي للبصر من الذين أصيبوا بهذا العجز بعد سنّ الخامسة.

- ويُلاحظ هنا أنه قد أتّخذ العنصر الزمني أساساً لهذا التقسيم، حيث اعتبر العام الخامس هو السنّ الذي يمكن التقسيم على أساسه، وذلك إنطلاقاً من أن الطفل الذي يفقد بصره قبل هذه السن لا يستطيع الإحتفاظ بالصوَر البصرية في ذهنه كما أكّدت بحوث "زولتان".

أما تصنيفات الإعاقة البصرية فهي عديدة ومختلفة أهمها:

- تصنيف الإعاقة البصرية من حيث الدرجة، وتتضمّن "مجموعة الإعاقة البصرية الكلية ـ مجموعة الإعاقة البصرية الجزئية".
- تصنيف الإعاقة البصرية من حيث السبب، وتتضمّن "مجموعة أسباب ما قبل الولادة وأثنائها وما بعد الولادة، والتي تتمثل فى العوامل البيئية والشخصية".
- تصنيف الإعاقة البصرية من حيث القدرة على الإبصار طبقاً لمقياس سنلن، وتتضمّن "مكفوفون كلياً تقلّ حدّة إبصارهم عن 200/20" ـ مكفوفون يستطيعون إدراك الحركة "تصل حدّة أبصارهم إلى

200/5" – مكفوفون يستطيعون القراءة "تصل حدّة إبصارهم إلى 200/10" - مكفوفون يستطيعون القراءة "تصل حدّة إبصارهم إلى أقل 200/20" - مكفوفون يستطيعون القراءة "تصل حدّة إبصارهم إلى 200/10"، إلا أن حدّة إبصارهم لا تؤهّلهم للحياة اليومية.

- تصنيف الإعاقة البصرية من حيث النوع، وتتضمّن (طول النظر - قصر النظر - صعوبة تركيز النظر - الإستجماتيزم - إلتهابات القرنية - الحوَل - تحرّك العين - عمى الألوان - فوبيا الضوء).

➢ **هذا ويكاد يتفق مَن يعملون في مجال الإعاقة البصرية على أن أسبابها ترجع إلى:**

1- أسباب تعود إلى ما قبل الولادة: وهي التي ترتبط بكل من العوامل الوراثية والبيئية، مثل "العوامل الجينية، الأمراض المُعدية، الحصبة الألمانية، العقاقير والأدوية، تعرّض الأمّ الحامل للأشعة السينية"، والتي تؤثر بدرجات متفاوتة على مدى نمو الجهاز العصبي المركزي للحواس، وتؤثر أيضاً على المراكز المخيّة الخاصة بحاسّة الإبصار، وهي أسباب في مجملها تتسبّب في كثير من أنواع الإعاقة المُحتملة والمتعدّدة، والتي من أمثلتها حالات قصر النظر وطول النظر وولادة الطفل كفيفاً كلياً أو جزئياً.

2- أسباب ترجع إلى ما بعد الولادة: وهي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بكثير من العوامل البيئية والشخصية مثل (التقدّم في العمر، سوء التغذية، الحوادث، الأمراض، إصابات العين)، والتي قد تؤدّي "إذا أهمل علاجها" إلى العمى أو ضعف حدّة الإبصار لدى الإنسان، وذلك كإصابة العين بالمياه البيضاء Cataract أو المياه الزرقاء Glaucoma أو إلتهاب التراكوما trachoma أو إلتهاب القزحية أو إلتهاب القرنية وغيرها من الأمراض التي تصيب جهاز العين بسبب العوامل البيئية التي يعيش فيها الإنسان أو التي تكون كامِنة قبل الولادة وتسهم العوامل البيئية في ظهورها في ما بعد، ولكل من الأمراض السابقة الذِكر أسبابها الوراثية أو البيئية التي تؤدّي إلى إصابة الإنسان بها.

- هذا ويشير المشتغلون في مجال طب العيون إلى كثير من الأسباب الأخرى التي تؤدّي إلى الإعاقة البصرية (العمى) أو ضعف حدة البصر، منها نقص فيتامين (أ)، وضعف الشبكية الناتج ن إصابة الإنسان بمرض السكر، وحدوث تليّف خلف العدسة، وإصابة العين ببعض الأورام، وإضطرابات الجهاز العصبي، وإصابة الإنسان بطول النظر أو إنفصال الشبكية أو ظهور العصب البصري وغيرها من الأسباب التي أجملها الأطباء وحدّدوها بناء على البحوث التجريبية في هذا المجال.

- أما أهم خصائص المعاقين بصرياً، فتتمثّل في إنخفاض مستوى الخبرات الحياتية لديهم بالقياس للخبرات الحياتية للناس العاديين، حيث أشارت نتائج دراسات العلماء وبحوثهم إلى قلّة خبرة الكفيف عن قرينه المُبصر، ذلك لأنه لا يستطيع أن يتحرّك بسهولة ويُسر أو يتمتّع بالمهارة الحركيّة نفسها التي يتمتّع بها قرينه المُبصر، وهذا من شأنه أن يعوّق عملية الرغبة لديه في الإستكشاف والمعرفة لما يدور حوله من أحداث وأشياء، الأمر الذي يجعله يشعر بالعجز المستمر، بإستثناء بعض الأفراد الذين يعوّضون هذا الفقد بطلب المساعدة من الآخرين في الكثير من أمور حياتهم، إضافة إلى إستخدام بقيّة حواسهم للمساعدة في

الإعتماد على الذات قدر الإمكان، إلا أنه وفي الوقت نفسه قد تقوى لدى المُعاق بصرياً الرغبة في الإتكالية وطلب العون والمساعدة من غيره في الكثير من أمور حياته، والشعور الزائد بذلك وما يترتّب عليه من رفض الذات، بحيث قد يصل الأمر إلى كراهيتها، وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى عدم القدرة على التوافق الإجتماعي .

الخاتمة

- الإعاقة البصرية ليست عائقًا يمنع الأشخاص من تحقيق النجاح في حياتهم. بفضل التقدم التكنولوجي والدعم المجتمعي، أصبح بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية العيش باستقلالية والمساهمة في المجتمع بشكل فعال. من المهم تعزيز الوعي بحقوقهم والعمل على دمجهم في مختلف مجالات الحياة لضمان فرص متساوية للجميع.

الإعاقة الذهنيه :

- وهي وتعرف أيضًا بالاضطراب العقلي النمائي أو عجز التعلم العام،

- وكانت تعرف سابقًا بالتخلف العقلي، هي اضطراب في النمو العصبي يتميز
- بضعف الأداء الفكري والتكيفي. تعرف الإعاقة الذهنية عندما يقل معدل ذكاء عن 70
- بالإضافة إلى عجز في سلوكين تكيفيين أو أكثر مما يؤثر على سلوكات الحياة اليوميه والعامه

اعاقه ذهنيه (Intellectual disability)

1 / طفل يجري خلال خط النهايه:

- يستطيع الأطفال المصابون بالإعاقة الذهنية أو الأمراض النمائية الأخرى
- المشاركة في الأولمبيات الخاصة.
- وتركز هذه الإعاقة على التعلم بشكل كامل تقريبا، يتضمن التعريف الآن عنصرا يتعلق
- بالأداء العقلي وآخر بمهارات الفرد الوظائفية في بيئته

على حد سواء. ونتيجة لهذا التركيز على قدرات الأشخاص في الواقع فإن فردًا بمعدل ذكاء منخفض بشكل غير عادي قد لا يعتبر معاقًا ذهنيًا

* الإعاقة الذهنية تقسم إلى

- الإعاقة الذهنية المتلازمة: وفيها تكون صعوبات التعلم مقترنة بعلامات وأعراض أخرى طبية ، وسلوكيه

- الإعاقة الذهنية غير المتلازمة: وفيها تظهر الصعوبات دون أن يرافقها علامات أخرى غير طبيعية. من الأمثلة على الإعاقة الذهنية المتلازمة: متلازمة داون ومتلازمة الكروموسوم الجنسي Xالهش.
- تصيب الإعاقة الذهنية لأسباب غير معروفة 95 مليون شخص حسب ما سجل عام 2013.
- أي ما يشكل 2-3% من مجموع السكان. 75-90% من المصابين لديهم
- إعاقة من الدرجة الخفيفة. يجدر بالذكر أن الإعاقة من الدرجة الخفيفة
- غير معروفة الأسباب تشكل ما نسبته 30-50% من الحالات.
- أما ربع الحالات تقريبا فهي بسبب اختلال جيني. المصطلحات المستخدمة لهذه

- الحالة خاضعة للتبديل المستمر للتخفيف من وقع التسميات. هذا يعني أنّه أيًّا كان المصطلح الّذي اختير لهذه الحالة فإنّه سيفهم مع الوقت على أنّه إهانه تقريبا فهي بسبب اختلال جيني. المصطلحات المستخدمة لهذه الحالة خاضعة للتبديل المستمر للتخفيف من وقع التسميات. هذا يعني أنّه أيًّا كان المصطلح الّذي اختير لهذه الحالة فإنّه سيفهم مع الوقت على أنّه إهانه

- وتم ابتكار المصطلحات (تخلّف عقلي) و (متخلّف عقليًّا) في منتصف القرن العشرين لاستبدال مجموعة المصطلحات السابقة، التي اعتبرت جارحة. ومع نهاية القرن العشرين صار ينظر إلى هذين المصطلحين -على نطاق واسع- على أنّهما مذمّتان جارحتان يجب استبدالهما. أما اليوم فيفضل
- المصطلح (إعاقة ذهنية) من قبل معظم المحامين والباحثين في معظم البلدان الناطقة
- بالإنجليزية. وبالنسبة للعام 2015، فإن المصطلح (تخلف عقلي) لا زال يستخدم من قبل

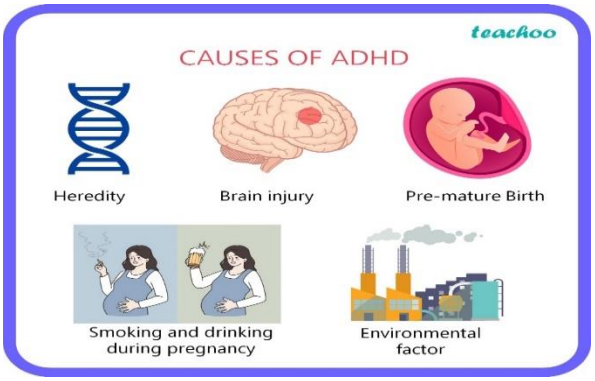
منظمة الصحة العالمية في المراجعة العاشرة

- للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-10)، حيث تحتوي على قسم تحت اسم «تخلف عقلي» في الفئات .F70-F79يتوقع استبدال «تخلف عقلي» في المراجعة القادمة ICD-11ب«إعاقة ذهنية» أو «اضطراب عقلي نمائي»، كما هو معتمد حاليا لدى الدليل الخامس لتشخيص الاضطرابات النفسية .DMS-5لا يزال المصطلح (تخلف عقلي) يستخدم في الأوساط الطبية المتخصصة حول العالم، وكذلك في أوراق البحث العلمي والتأمين الصحي

أسباب الإعاقة الذهنية

الإعاقات العقلية وصعوبات التعلم

- تكون القدرات العقلية للمصاب بالإعاقة الذهنية محدودة، فهو يُعاني من مشاكل في القدرة على التعلم، واتخاذ القرارات وحل المشاكل، كما قد يُواجه صعوبة كبيرة في فهم اللغة واستخدامها، وعادةً يحتاج المصاب بهذه الحالة إلى الرعاية والتوجيه طوال الوقت؛ حيث لا يكون قادرًا على القيام بمهامه اليومية وحده دون مساعدة،وعادةً تظهر أعراض الإعاقة الذهنية في مرحلة مبكرة من حياة المصاب، فما هي أسباب الإعاقة الذهنية؟



الأمراض الوراثية

- تُعد الأمراض الوراثية من الأسباب الشائعة للإعاقة الذهنية، وتتضمّن عادةً الحالات الآتية

الأمراض الناجمة عن خلل الكروموسومات: *

- يُمكن أن تُسبب هذه الأمراض الإعاقة الذهنية،
- ومن الأمثلة عليها الأمراض الآتية:

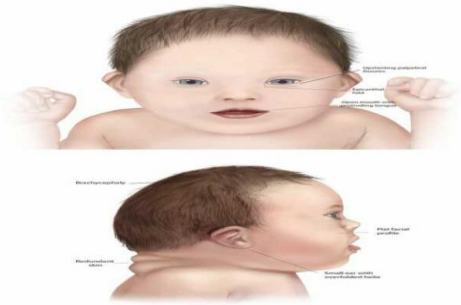
متلازمة كروموسوم: X* الهش

- تحدث هذه الحالة نتيجةً لحدوث خللٍ في كروموسوم Xوحدوث طفرة فيه، مما يُؤثر على الملامح الجسدية لدى المصاب، والذي يُعاني من صعوبات التعلم أيضًا، ويكون مستوى الذكاء لديه منخفضا

*** متلازمة داون:**

- تحدث هذه الحالة عندما يمتلك المصاب نسخة إضافية من الكرموسوم
- الذي يحمل الرقم 21، مما يُسبب الإعاقة الذهنية لديه، والتي
- تكون طفيفة أو متوسطة في العادة
- حدوث مشاكل ومضاعفات أثناء الحمل *
- قد تحدث الإعاقة الذهنية عند عدم نمو دماغ المصاب بشكلٍ صحيح أثناء الحمل، ومن أبرز الأسباب التي قد تُؤدي لذلك الآتي

تناول الكحول:



- تناول الأم للكحول أثناء الحمل قد يُسبب متلازمة اضطراب طيف الكحول الجينية،
- وهي حالة صحية ترتبط بانخفاض معدل الذكاء وصعوبات الإدراك المعرفي.

سوء التغذية:

- قد تحدث الإعاقة الذهنية إذا كانت الأم الحامل تُعاني من سوء التغذية الشديد .

الإصابة بالعدوى:

- قد يُصاب الجنين بالإعاقة الذهنية إذا أصيبت الأم بأمراض كالحصبة الألمانية والهربس مثلًا.

التعرض للتسمم:

- وهذا قد يحدث إذا تعرضت الأم الحامل لمواد خطيرة كالرصاص والزئبق.

حدوث مشكلة أثناء الولادة: -

- قد يُصاب الطفل بالإعاقة العقلية عند ولادته بشكلٍ مبكرٍ جدًا، أو في حال
- أصيب بنقص الأكسجين أثناء الولادة، وهذا قد يحدث في حال التف الحبل السري
- حول رقبته أثناء الولادة؛ فهذا سيُعيق وصول الأكسجين إلى الدماغ.

التعرض لإصابة في الدماغ: -

- يُمكن أن تُسبب إصابات الرأس الشديدة تلفًا في الدماغ، الأمر الذي يُؤدي للإصابة بالإعاقة الذهنية،
- حيث قد يُعاني المصاب في هذه الحالة من مشاكل في قدراته المعرفية كالذاكرة،

والقدرة على التفكير، وقد تحدث هذه الإصابات عند التعرض لحادث أو ممارسة

- بعض الرياضات العنيفة.

أسباب اخرى:

- قد تحدث الإعاقة الذهنية أيضًا نتيجةً للأسباب الآتية:

1- الإصابة بالتهاباتٍ في الدماغ والتهاب السحايا
2- التعرض للعنف العاطفي والإهمال الشديد
3- وجود ورم في الدماغ
4- التسمم بمواد خطيرة

تصنيفات الإعاقة الذهنية

- يتم تصنيف الإعاقة الذهنية بناءً على

1- القدرة علي التكييف مع الحياه اليوميه وفقا للجمعيه الالمريكيه للاعاقه الذهنيه والتنموية (IQمستوي

2- ومنظمه الصحه العالميه ويمكن تصنيف الاعاقه الذهنيه الي الفئات التاليه : (AAIDD)

(Mild Intellectual Disability) - الاعاقه الذهنيه البسيطة

- بين 70-50 (IQ) معدل الذكاء
- يمكنهم العيش باستقلالية مع بعض الدعم
- يستطيع الأفراد في هذه الفئة تعلم مهارات أكاديمية ومهنية بسيطة.

(Moderate Intellectual Disability) - الاعاقة الذهنيه المتوسطه

- 49-35بين (IQ): مستوي الذكاء
- يحتاجون إلى دعم في المهارات الحياتية والتكيف الاجتماعى
- يمكنهم تعلم بعض المهارات الوظيفية والاعتماد على أنفسهم جزئيًا

(Severe Intellectual Disability") - الاعاقة الذهنية الشديد

- بين 20-34(IQ معدل الذكاء
- يواجهون صعوبات كبيرة في التكيف مع الحياة اليومية ويحتاجون إلى إشراف دائم
- يعتمدون على الآخرين في معظم جوانب الحياة مثل الأكل واللباس

(Profound Intellectual Disability) - الإعاقة الذهنية العميقة

- اقل من 20(IQ معدل الذكاء
- يعانون من تأخر شديد في النمو الجسدي والعقلي
- يحتاجون إلى رعاية دائمة ودعم مكثف في جميع جوانب الحياة

خصائص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

- الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية يختلفون في قدراتهم وفقًا لدرجة الإعاقة، لكنهم يشتركون في بعض الخصائص العامة:

1- الخصائص العقلية:

- تأخر في اكتساب المهارات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة والحساب.
- . ضعف القدرة على التفكير المنطقي وحل المشكلات
- بطء في استيعاب المعلومات والتعلم مقارنةً بالأقران.

2- الخصائص الاجتماعية:

- صعوبة في فهم القواعد الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين.
- ضعف المهارات اللغوية والتواصلية، مما يؤثر على القدرة على التعبير عن الاحتياجات والمشاعر.
- قد يظهر لديهم سلوكيات غير مناسبة اجتماعيًا بسبب قلة الوعي بالمواقف.

3- الخصائص الحركية:

- قد يكون لديهم تأخر في المهارات الحركية مثل المشي والتوازن .
- بعض الحالات تعاني من ضعف التناسق الحركي والقدرة على تنفيذ الحركات الدقيقة.

الخصائص العاطفية والسلوكية:

- يمكن أن يعانوا من مشاكل سلوكية مثل فرط النشاط أو العدوانية أو القلق .
- قد يكون لديهم صعوبة في ضبط العواطف والاستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة.
- يحتاجون إلى استراتيجيات دعم نفسي وتربوي لتحسين سلوكهم وتكيفهم

* تشخيص الاعاقه الذهنية :

التقييمات النفسية:

1- اختبار الذكاء: يُستخدم لقياس الذكاء والقدرات المعرفية.
2- اختبار الشخصية: يُستخدم لقياس الشخصية.
3- اختبار السلوك: يُستخدم لقياس السلوك والتفاعل الاجتماعي

التقييمات الطبية:

1. لفحص الطبي: يُجرى فحص طبي شامل لاستبعاد أي مشاكل صحية قد تؤثر على الذكاء
2. اختبار الدم: يُجرى اختبار دم لتحديد أي مشاكل صحيه قد تؤثر علي الذكاء
3. 3 . ختبار التصوير الطبي: يُجرى اختبار التصوير الطبي

- مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)أو التصوير المقطعي المحوسب (CT)لتحديد أي مشاكل صحية قد تؤثر على الذكاء

التقييمات التربوية :

1. اختبار الإنجاز الأكاديمي: يُستخدم لقياس الإنجاز الاكاديمي والقدرات التعليمية
2. اختبار المهارات الحياتية: يُستخدم لقياس المهارات الحياتية والقدرات الوظيفية

التقييمات السلوكية :

1. مقياس السلوك: يُستخدم لقياس السلوك والتفاعل الاجتماعي.
2. مقياس الانتباه: يُستخدم لقياس الانتباه والتركيز.

الأشخاص المعنيون بالتشخيص :

1. الأطباء النفسيون: يُشخصون الصعوبات النفسية.
2. الأطباء العصبيون: يُشخصون الصعوبات العصبية.
3. لمعلمون المتخصصون: يُشخصون الصعوبات التعليمية
4. الأخصائيون النفسيون: يُشخصون الصعوبات النفسية .

المعايير التشخيصية :

- 1DSM-5:- الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية: يُستخدم لتشخيص الإعاقة الذهنية

- ICD-1):- يُستخدم لتشخيص الإعاقة الذهنية: التصنيف الدولي للأمراض

- لتقييم الإعاقة الذهنية :

1. اختبار ستانفورد بينيت: يُستخدم لقياس الذكاء والقدرات المعرفيه
2. اختبار ويكسلر للذكاء: يُستخدم لقياس الذكاء والقدرات المعرفيه

- تقييم المهارات الحياتية :

1. مقياس المهارات الحياتية: يُستخدم لقياس المهارات الحياتية والقدرات الوظيفية
2. مقياس الاستقلال الشخصي: يُستخدم لقياس الاستقلال الشخصي والقدرات الوظيفيه

- تقييم المهارات الاجتماعية :

1. مقياس المهارات الاجتماعية: يُستخدم لقياس المهارات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي
2. قياس التواصل الاجتماعي: يُستخدم لقياس التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي

- تقييم المهارات الأكاديمية :

1. مقياس الإنجاز الأكاديمي: يُستخدم لقياس الإنجاز الأكاديمي والقدرات التعليمية
2. مقياس المهارات القرائية: يُستخدم لقياس المهارات القرائية والقدرات التعليمية

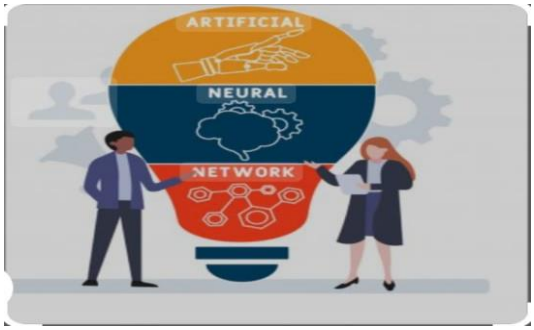
- تقييم المهارات الوظيفية :

1. مقياس المهارات الوظيفية: يُستخدم لقياس المهارات الوظيفية والقدرات الوظيفيه
2. مقياس الاستقلالية الوظيفية: يُستخدم لقياس الاستقلالية الوظيفية والقدرات الوظيفية

* الأشخاص المعنيون بالتقييم :

1. الأطباء النفسيون: يقومون بتقييم الصعوبات النفسية .
2. الأطباء العصبيون: يقومون بتقييم الصعوبات العصبية.
3. المعلمون المتخصصون: يقومون بتقييم الصعوبات التعليمية.
4. لأخصائيون النفسيون: يقومون بتقييم الصعوبات

* التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة الذهنية :

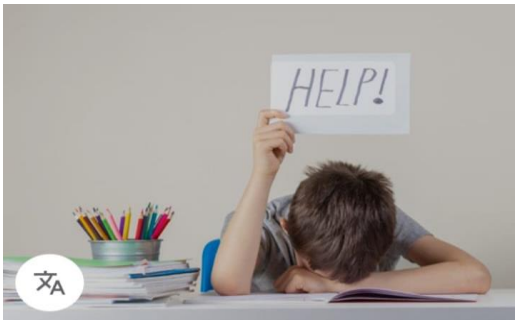


- ذوي الإعاقة الذهنية يواجهون العديد من التحديات في حياتهم اليومية. هذه التحديات يمكن أن تشمل :

- التحديات الاجتماعية :

1. التمييز والتحيز: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من التمييز والتحيز في المجتمع.
2. نقص الدعم الاجتماعي: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من نقص الدعم الاجتماعي والرعاية.

- التحديات النفسية :

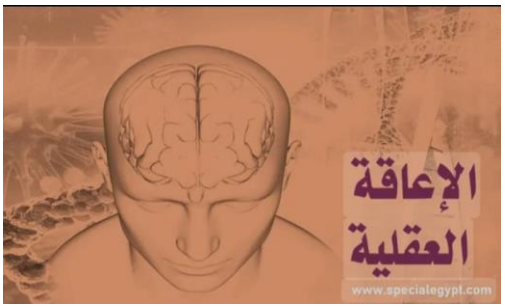


1. الاكتئاب والقلق: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من الاكتئاب والقلق .
2. نقص الثقة بالنفس: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من نقص الثقة بالنفس.

- التحديات التعليمية :

1. نقص فرص التعليم: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من نقص فرص التعليم.
2. صعوبة التعلم: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من صعوبة التعلم .

- التحديات الصحية :



1. نقص الرعاية الصحية: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من نقص الرعاية الصحية.
2. صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية

- التحديات الاقتصادية :

1. نقص فرص العمل: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من نقص فرص العمل.
2. صعوبة الوصول إلى الموارد الاقتصادية: يعاني ذوي الإعاقة الذهنية من صعوبة الوصول إلى الموارد الاقتصادية

- هذه التحديات يمكن أن تؤثر على جودة حياة ذوي الإعاقة الذهنية، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال تقديم الدعم والرعاية المناسبة

الاعاقه الحسيه

تعريف الإعاقة والإعاقة الحسية

الإعاقة :

- هي حالة تؤثر على قدرة الفرد على أداء أنشطة الحياة بشكل طبيعي نتيجة خلل في القدرات البدنية، الحسية، العقلية، أو النفسية.

الإعاقة الحسية:

- اضطراب يؤثر على حاسة أو أكثر (مثل البصر، السمع، اللمس) مما يعيق قدرة الشخص على التفاعل مع البيئة

أنواع الإعاقة الحسية:

الإعاقة البصرية:

- تشمل ضعف البصر أو العمى الكلي.
- يمكن التعامل معها عبر أجهزة مساعدة مثل نظارات بصرية أو قراءة برايل.

الإعاقة السمعية:

- تشمل ضعف السمع أو الصمم الكلي.
- يتم التعامل معها باستخدام سماعات طبية أو زراعة القوقعة.

الإعاقة المزدوجة:

- تشمل فقدان السمع والبصر معًا (الصمم-العمى).
- تتطلب أساليب تواصل معقدة تجمع بين الإشارة واللمس.

أسباب الإعاقة الحسية:

- وراثية :عيوب جينية تنتقل عبر العائلة.
- إصابات الولادة :مثل نقص الأكسجين أثناء الولادة.
- الأمراض :مثل التهاب السحايا والحصبة.
- الإصابات والصدمات :الناتجة عن حوادث تؤثر على الأعصاب أو الأجهزة الحسية.
- التقدم في العمر :يؤدي إلى ضعف السمع أو البصر.

التحديات التي يواجها الأفراد ذوو الإعاقة الحسية:

- التواصل :صعوبة في الفهم أو التعبير عن النفس.
- العزلة الاجتماعية :قلة فرص التفاعل مع الآخرين.
- صعوبة التعلم والعمل :بسبب نقص الأدوات الداعمة.
- التأثير النفسي :مثل القلق والاكتئاب الناتج عن التمييز أو العزلة.

تشخيص الإعاقات الحسية:

1. الفحوصات الطبية :مثل اختبارات السمع والرؤية.
2. التقييمات النفسية والتعليمية :لفهم تأثير الإعاقة على التعلم والسلوك.
3. التقييم البيئي :لمعرفة مدى تأثير الإعاقة على حياة الفرد اليومية.

طرق العلاج والتأهيل:

1. الأجهزة المساعدة :مثل السماعات الطبية، نظارات بصرية، أو أجهزة برايل.
2. العلاج الطبي والجراحي :مثل زراعة القوقعة أو إصلاح عيوب البصر.
3. التأهيل الحسي :تدريب الحواس المتبقية لتحسين التفاعل.
4. الدعم النفسي والاجتماعي :للحد من العزلة وبناء الثقة بالنفس.
5. تقنيات التأقلم :مثل التطبيقات المساعدة لتسهيل التواصل.

ميزات الإعاقة الحسية:

- تطوير حواس أخرى لتعويض الحاسة المفقودة.
- تحسين مستوى التركيز والانتباه.

- الابتكار في وسائل التواصل مثل استخدام برايل أو لغة الإشارة.
- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستقلالية.

دور المجتمع في دعم ذوي الإعاقة الحسية:

1. التوعية :تعزيز الوعي المجتمعي بالاحتياجات والتحديات.
2. البنية التحتية :تصميم بيئات مهيأة تسهل التنقل والتفاعل.
3. التعليم والوظائف :توفير فرص تعليمية ومهنية متكافئة.
4. الخدمات الداعمة :الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة والرعاية الصحية.

التوصيات:

- زيادة الوعي المجتمعي لتعزيز الشمولية.
- توفير برامج تعليمية ومهنية متخصصة.
- دعم البحث العلمي لتطوير تقنيات مساعدة جديدة.
- ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات.

أهمية التوعية المجتمعية بدعم ذوي الإعاقة الحسية

التوعية المجتمعية تُعد حجر الأساس لتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الحسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

- تنظيم حملات توعية :لتعريف الجمهور بأهمية دعم ذوي الإعاقة وتقبلهم كجزء من المجتمع.
- إشراك الإعلام :في بث قصص نجاح وبرامج تركز على إمكانيات ذوي الإعاقة الحسية.
- تثقيف الأطفال والشباب :لتعزيز التقبل والاندماج من خلال الأنشطة التعليمية.

دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين حياة ذوي الإعاقة الحسية

- الأجهزة الذكية مثل النظارات الرقمية للمكفوفين وسماعات الأذن الذكية لضعاف السمع .
- التطبيقات المبتكرة التي تُحوّل النصوص إلى صوت والصوت إلى نصوص.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل محيط المكفوفين وإرشادهم أثناء التنقل.

التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الأفراد ذوي الإعاقة الحسية

- الشعور بالعزلة :بسبب قلة التفاعل مع الآخرين.
- القلق والاكتئاب :نتيجة الصعوبات اليومية.
- التمييز المجتمعي :نقص الوعي يؤدي إلى التهميش وعدم تكافؤ الفرص.

التوصيات لمجتمع أكثر شمولية

- توفير البنية التحتية الداعمة :مثل اللافتات الصوتية والمرئية في الأماكن العامة.
- تشجيع البرامج التعليمية المتخصصة :لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة الحسية على تعليم ملائم.
- تعزيز الشمولية في سوق العمل :من خلال تقديم تدريبات مهنية للاندماج في الوظائف.

أمثلة نجاح وإلهام

- هناك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحسية الذين نجحوا في مختلف المجالات مثل الفن، والتكنولوجيا، والسياسة، مما يبرز قدرتهم على التأقلم والإبداع رغم التحديات.

الإعاقة التعليمية

المقدمة

- الإعاقات التعليمية تؤثر على قدرة الفرد في التعلم الأكاديمي والفكري، مما يسبب صعوبات في القراءة، الكتابة، الرياضيات، أو الفهم العام للمعلومات.
- تتعدد أسباب هذه الإعاقات، فقد تكون وراثية، بيئية، أو نفسية. وعلى الرغم من أن الشخص قد يمتلك ذكاءً طبيعيًا أو حتى فوق المتوسط، إلا أنه يواجه صعوبة في معالجة المعلومات بالطريقة التقليدية.

- يتطلب دعم هؤلاء الأفراد تكييف بيئة التعلم واتباع أساليب تعليمية خاصة لتحسين أدائهم الأكاديمي. من أمثلة هذه الإعاقات: عسر القراءة، عسر الكتابة، اضطرابات الانتباه، وصعوبات الرياضيات.

الأهداف

- تهدف الإعاقة التعليمية إلى:

1. توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي صعوبات التعلم.
2. تحسين الأداء الأكاديمي من خلال استراتيجيات تدريس مخصصة.
3. تنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية لتعزيز الثقة بالنفس والتواصل.
5. تعزيز الاستقلالية ومهارات حل المشكلات.
6. دمج الطلاب في المجتمع وزيادة فرص التفاعل والمشاركة.
7. دعم أولياء الأمور والمعلمين بمعلومات وأدوات فعالة.

مميزات الإعاقة التعليمية

1. تطوير مهارات حل المشكلات: يضطر الأفراد للبحث عن حلول بديلة، مما يعزز تفكيرهم النقدي والإبداعي.
2. التحفيز على الإبداع والابتكار: قد تدفعهم القيود إلى إيجاد طرق جديدة لاكتساب المعرفة.
3. زيادة المثابرة والصبر: تجعل الشخص أكثر تصميمًا على تحقيق أهدافه.
4. تحفيز البحث والاستكشاف: يصبح الأفراد أكثر فضولًا لاكتشاف طرق جديدة للفهم.
5. تعزيز التعاطف والتعاون: من يعاني من تحديات يكون أكثر تفهمًا لمشاكل الآخرين.
6. تطوير استراتيجيات تعلم جديدة: مثل الخرائط الذهنية أو التطبيقات التفاعلية.
7. تحفيز العمل الجماعي: يساعدهم على التواصل الفعّال مع زملائهم ومعلميهم.
8. تعزيز القدرة على التكيف: يجعلهم أكثر مرونة في مواجهة التحديات.
9. تطوير مهارات التفكير النقدي: يساعدهم على تقييم المعلومات والتحقق من صحتها.
10. إمكانية اكتشاف مجالات جديدة من خلال البحث عن طرق بديلة للتعلم.

الحاجات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة التعليمية

- تشمل تحديات تؤثر على تعلمهم، مثل:

1. صعوبات القراءة والكتابة (عسر القراءة والكتابة) – صعوبة في تمييز الحروف أو فهم النصوص.
2. مشكلات استيعاب الرياضيات (عسر الحساب) – صعوبة في فهم الأرقام والعمليات الحسابية.
3. اضطرابات الانتباه والتركيز (مثل ADHD) – صعوبة في التركيز لفترات طويلة.
4. بطء في معالجة المعلومات – الحاجة إلى وقت أطول لفهم المفاهيم.
5. مشكلات في التناسق الحركي (عسر الكتابة) – تؤثر على الكتابة بشكل صحيح وسريع.
6. ضعف الذاكرة العاملة – صعوبة في تذكر التعليمات والمعلومات بسرعة.

كيف يمكن دعمهم؟

1. توفير استراتيجيات تعليمية مخصصة مثل استخدام الوسائط المتعددة.
2. التقييم المستمر وتعديل أساليب التدريس بناءً على احتياجاتهم.
3. الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
4. استخدام التكنولوجيا المساعدة مثل التطبيقات الداعمة للقراءة والكتابة.

سمات الإعاقة التعليمية

1- السمات الأكاديمية

- صعوبة في القراءة (عسر القراءة) أو الكتابة (عسر الكتابة) أو الحساب (عسر الحساب).
- بطء في تعلم المهارات الأساسية مقارنةً بالأقران.
- أخطاء متكررة في الإملاء أو القراءة أو العمليات الحسابية.
- ضعف في استيعاب وحفظ المعلومات الجديدة.
- مشكلات في تنظيم الأفكار عند الكتابة أو التحدث.

2- السمات المعرفية والإدراكية

- ضعف في الانتباه والتركيز لفترات طويلة.
- صعوبة في التذكر واسترجاع المعلومات عند الحاجة.
- صعوبة في حل المشكلات أو تطبيق المعرفة في مواقف جديدة.
- صعوبة في فهم التعليمات المعقدة أو اتباعها.

3- السمات السلوكية والعاطفية

- الإحباط والتوتر السريع عند محاولة التعلم.
- تجنب الأنشطة التعليمية أو الشعور بعدم الثقة بالنفس.
- تشتت الانتباه وسرعة فقدان الاهتمام بالمهمة.
- صعوبة في التعامل مع الضغوط الدراسية والشعور بالإحباط بسهولة.

4- السمات الاجتماعية والتواصل

- صعوبة في التعبير عن الأفكار بوضوح.
- مشكلات في التواصل اللفظي وغير اللفظي.
- تجنب التفاعل الاجتماعي بسبب الشعور بالخجل أو الفشل.
- صعوبة في فهم المشاعر والإشارات الاجتماعية.

تشخيص الإعاقة التعليمية

- هو عملية تقييم متعددة الجوانب تهدف إلى تحديد وجود صعوبات تعلمية لدى الطالب، ومعرفة مدى تأثيرها على أدائه الأكاديمي، ثم وضع خطة لدعمه، وتشمل عدة خطوات:

1- الملاحظة الأولية: يلاحظ المعلم أو الأهل أداء الطالب في المدرسة أو المنزل، مثل صعوبة القراءة أو الكتابة أو الحساب.
2- التقييم الأكاديمي: يتم إجراء اختبارات رسمية وغير رسمية لقياس مستوى الأداء مقارنة بأقرانه.
3- التقييم النفسي والمعرفي: يشمل اختبارات الذكاء، وتقييم الوظائف المعرفية مثل الانتباه، والذاكرة، وحل المشكلات.
4- التقييم اللغوي والنطقي: للتحقق من وجود مشاكل في النطق أو فهم اللغة التي قد تؤثر على التعلم.
5- التقييم العصبي والطبي: لاستبعاد أي مشكلات جسدية أو عصبية قد تكون السبب.
6- جمع المعلومات من مصادر متعددة: مثل المعلمين، والأهل، والاستبيانات، والمقاييس السلوكية.
7- وضع خطة دعم فردية: بناءً على نتائج التقييم، يتم تصميم خطة لدعم الطالب تشمل تعديلات في أساليب التدريس أو استخدام تقنيات مساعدة.

الإعاقة التعليمية

- تشير إلى صعوبة في واحدة أو أكثر من العمليات العقلية الأساسية المتعلقة بالفهم أو استخدام اللغة، مما يؤثر على القدرة في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو الاستماع أو التحدث أو التفكير.

1- علامات في الطفولة المبكرة (ما قبل المدرسة)

- تأخر في الكلام أو صعوبة في نطق الكلمات بشكل صحيح.
- مشاكل في تعلم الحروف أو الأرقام أو الألوان أو الأشكال.
- صعوبة في تذكر المعلومات البسيطة.

- ضعف في المهارات الحركية الدقيقة، مثل الإمساك بالقلم أو استخدام المقص.
- صعوبة في اتباع التعليمات أو ترتيب الأحداث.

2- علامات في المرحلة الابتدائية

- صعوبة في تعلم القراءة (مثل الخلط بين الحروف أو الكلمات).
- مشاكل في الكتابة، مثل الأخطاء الإملائية الكثيرة أو عكس الحروف.
- بطء في تعلم العمليات الحسابية الأساسية.
- صعوبة في الفهم والاستيعاب، حتى عند القراءة بصوت عالٍ.
- ضعف في التركيز والانتباه، وسرعة التشتت.
- تجنب الواجبات المدرسية أو الشعور بالإحباط الشديد منها.

3- علامات في المرحلة الإعدادية والثانوية

- ضعف في تنظيم الأفكار عند الكتابة أو التعبير الشفهي.
- مشاكل في استيعاب النصوص الطويلة أو الملخصات.
- ضعف في حل المسائل الرياضية متعددة الخطوات.
- صعوبة في تذكر الجداول الزمنية أو ترتيب الأحداث.
- تجنب القراءة أو الكتابة أمام الآخرين.
- صعوبة في إدارة الوقت والالتزام بالمواعيد.

4- علامات عامة في جميع المراحل

- القلق أو الإحباط المتكرر تجاه الدراسة.
- ضعف الثقة بالنفس والشعور بالعجز مقارنة بالزملاء.
- صعوبة في التكيف مع التغييرات في بيئة التعلم.
- الميل إلى تجنب الأنشطة التي تتطلب تركيزًا كبيرًا.
- إذا ظهرت هذه العلامات بشكل متكرر وأثرت على الأداء الدراسي، فقد يكون من الضروري استشارة مختص في صعوبات التعلم لتقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب.

الإعاقة التعليمية عند الأطفال

- الإعاقة التعليمية تعني وجود صعوبة مستمرة في اكتساب المهارات الأكاديمية مثل القراءة، الكتابة، أو الحساب، رغم الذكاء الطبيعي للطفل. وتظهر هذه الإعاقة من خلال مجموعة من العلامات التي تؤثر على الأداء التعليمي.

العلامات الدالة على الإعاقة التعليمية عند الأطفال

1. صعوبات في القراءة والكتابة
- عدم القدرة على التعرف على الحروف أو تذكرها.
- صعوبة في التهجئة وكتابة الكلمات بشكل صحيح.
- قراءة بطيئة ومتقطعة مع نطق غير دقيق للكلمات.
- تجنب القراءة أو الشعور بالإحباط عند محاولة القراءة.

2. مشاكل في الحساب والرياضيات
- صعوبة في التعرف على الأرقام أو ترتيبها.
- عدم فهم العمليات الحسابية الأساسية.
- الاعتماد على الأصابع دائمًا في الحساب.
- صعوبة في فهم الوقت أو التعامل مع المال.

3. ضعف الانتباه والتركيز
- تشتت سريع وصعوبة في اتباع التعليمات.
- نسيان المهام أو فقدان الأدوات المدرسية باستمرار.
- عدم القدرة على إنهاء الواجبات أو المشاريع المدرسية.

4. صعوبات في التناسق الحركي والمهارات الحركية الدقيقة
- صعوبة في الإمساك بالقلم أو استخدام الأدوات المدرسية.
- خط سيئ أو بطء في الكتابة بخط اليد.
- صعوبة في ربط الحذاء أو ارتداء الملابس.

5. مشاكل في اللغة والتواصل
- تأخر في التحدث مقارنة بالأطفال في نفس العمر.
- صعوبة في التعبير عن الأفكار أو العثور على الكلمات المناسبة.
- ارتباك بين الكلمات المتشابهة في النطق أو المعنى.

6. صعوبات في الذاكرة والتذكر
- نسيان ما تم تعلمه بسرعة.
- صعوبة في استرجاع المعلومات عند الحاجة.
- تكرار الأسئلة رغم الإجابة عليها مسبقًا.

7. مشاكل في السلوك والتفاعل الاجتماعي
- تجنب الأنشطة الجماعية أو اللعب مع الآخرين.
- الإحباط أو الغضب السريع عند محاولة التعلم.
- تدني الثقة بالنفس بسبب الأداء الأكاديمي الضعيف.

التحديات المرتبطة بالإعاقة التعليمية

1) صعوبات في القراءة والكتابة (مثل عسر القراءة - Dyslexia).
2) مشاكل في الرياضيات (عسر الحساب - Dyscalculia).
3) ضعف التركيز والانتباه (خاصة لدى المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة - ADHD).
4) بطء في معالجة المعلومات وصعوبة في استيعاب المفاهيم الجديدة.
5) مشاكل في الذاكرة تؤثر على استرجاع المعلومات.
6) ضعف المهارات الاجتماعية والتواصلية مما يؤثر على الاندماج مع الآخرين.
7) الإحباط وضعف الثقة بالنفس نتيجة الفشل المتكرر.
8) الحاجة إلى طرق تدريس خاصة مثل التعليم الفردي أو الوسائل التكنولوجية المساعدة.
9) صعوبة في تنظيم الأفكار والتخطيط مما يؤثر على إنجاز المهام المدرسية.
10) بطء في اكتساب المهارات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة والحساب.
11) مشاكل في اتباع التعليمات وفهم التوجيهات المتعددة الخطوات.
12) الارتباك عند التعامل مع معلومات جديدة مما يصعب التكيف مع المناهج المختلفة.
13) مشاكل في التمييز بين الحروف أو الأصوات المتشابهة.
14) الإجهاد الذهني السريع بسبب المجهود الإضافي المطلوب للتركيز والتعلم.
15) التوتر والقلق الأكاديمي نتيجة مواجهة صعوبات التعلم.

16) ضعف التنسيق الحركي الدقيق (مثل عسر الكتابة - Dysgraphia).
17) عدم الاستجابة للوسائل التقليدية في التعلم واحتياج طرق بصرية أو تفاعلية.
18) سهولة التشتت الذهني والحساسية العالية للمشتتات البيئية.
19) ضعف مهارات حل المشكلات مما يؤثر على القدرة على التحليل والاستنتاج.
20) تفاوت الأداء الأكاديمي حيث يكون الطفل متميزًا في بعض المواد وضعيفًا جدًا في مواد أخرى.

الخاتمة

- في ختام الحديث عن الإعاقة التعليمية، لا بد من التأكيد على أن لكل طفل الحق في التعليم، بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها. فالإعاقة التعليمية ليست عائقًا أمام النجاح، بل تتطلب استراتيجيات خاصة ودعمًا مناسبًا يساعد الطفل على تطوير قدراته بأفضل طريقة ممكنة.
- إن بناء بيئة تعليمية داعمة يتطلب تكاتف الجهود بين المعلمين، الأسرة، والمجتمع، لضمان تكافؤ الفرص للجميع. فالتفهم والدعم هما المفتاح لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة التعليمية على تحقيق إمكاناتهم، والاندماج في المجتمع، ليكونوا أفرادًا فاعلين ومؤثرين في المستقبل.

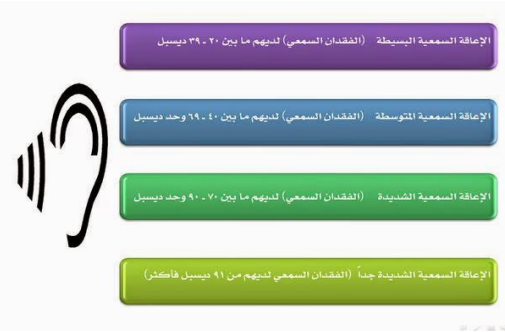
الإعاقة السمعية

المقدمة:

- الإعاقة السمعية هي مصطلح يشمل درجات مختلفة من فقدان السمع، بدءًا من الفقدان الخفيف وصولًا إلى الصمم التام.
- قد تكون هذه الإعاقة واضحة أو غير ملحوظة، مما قد يؤدي إلى مشكلات في حياة الطفل، مثل الفشل الدراسي وسوء التفاعل الاجتماعي، حيث يُساء فهم حالته ويُوصف بالغباء. كما قد تكون الإعاقة السمعية مصاحبة لأنواع أخرى من الإعاقات.

مفهوم الإعاقة السمعية

- تعرف الإعاقة السمعية على أنها ضعف أو فقدان في القدرة على السمع، والذي قد يكون ناتجًا عن تغير في البنية أو الوظيفة السمعية، مما يعيق أداء الشخص في أنشطة الحياة اليومية.
- تتراوح الإعاقة السمعية بين الفقدان الخفيف والكامل، ويمكن أن تؤثر على أذن واحدة أو كلتا الأذنين.



أسباب الإعاقة السمعية :

- العوامل الجينية.
- العدوى أثناء الحمل أو بعد الولادة.
- الإصابات الرأسية.
- التعرض للضوضاء المفرطة.
- بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تأثيرات الإعاقة السمعية على الحياة:

- صعوبة في التواصل والتفاعل مع الآخرين .
- مشكلات في التعلم والاستيعاب.
- تحديات في فرص العمل والتعليم.
- صعوبة في التكيف مع البيئة المحيطة.

طرق التغلب على الإعاقة السمعية:

- استخدام الأجهزة السمعية.
- تعلم لغة الإشارة.
- اللجوء إلى تقنيات التواصل البديلة.
- الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.

أهداف تعليم المعوَّقين سمعيًا

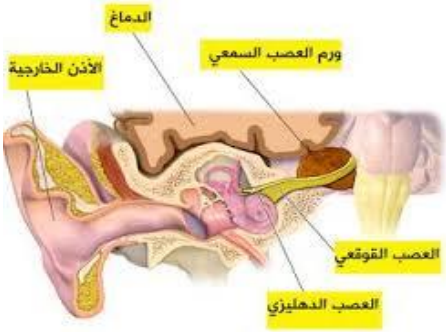
1. تدريبهم على النطق والكلام لتحسين القدرة اللغوية .
2. تطوير مهارات الاتصال مع المجتمع.
3. التقليل من الآثار العقلية، النفسية، والاجتماعية للإعاقة.
4. تعزيز السلوكيات الإيجابية ليكونوا أفرادًا صالحين.
5. تزويدهم بالمعرفة اللازمة لفهم بيئتهم.
6. تدريبهم مهنيًا لتحقيق الاستقلالية المالية.
7. مساعدتهم على مواكبة التطور والتقدم.
8. تحسين مستوى معيشتهم بعد التخرج.
9. تعزيز شعورهم بالقيمة داخل المجتمع.

أنواع الإعاقة السمعية

- الإعاقة السمعية الخفيفة :يسمع الفرد الأصوات لكن بوضوح ضعيف.
- الإعاقة السمعية المعتدلة :يسمع الفرد الأصوات لكن ليس بوضوح كافٍ.

- الإعاقة السمعية الشديدة :لا يسمع الفرد إلا الأصوات القوية جدًا.
- الإعاقة السمعية الكاملة :لا يستطيع الفرد سماع أي أصوات.

أسباب الإعاقة السمعية



- العوامل الجينية.
- العدوى أثناء الحمل أو بعد الولادة (مثل التهاب السحايا والحصبة).
- الإصابات الرأسية الناجمة عن الحوادث.
- التعرض للضوضاء المفرطة .
- أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

أعراض الإعاقة السمعية

- صعوبة في السمع.
- صعوبة في فهم الكلام.
- صعوبة في التواصل مع الآخرين.
- مشكلات في التعلم.

أهداف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

- تحسين الوصول إلى المعلومات عبر الترجمة الفورية والتقنيات المساعدة.
- تعزيز مهارات التكيف الشخصي لتسهيل الحياة اليومية.
- تطوير سياسات دعم اجتماعي وصحي لضمان الرعاية الملائمة.
- دعم البحث العلمي لتطوير تقنيات العلاج والتعلم.
- تعزيز التعاون بين المؤسسات لتوفير بيئة شاملة وداعمة.
- زيادة فرص المشاركة الثقافية والترفيهية من خلال الأنشطة المناسبة.
- تدريب الأسر على التعامل مع الإعاقة السمعية لدعم أفرادها.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل مترجمي الإشارة والسماعات المتطورة.
- تحسين مهارات التواصل عبر لغة الإشارة وقراءة الشفاه.

- توفير بيئة تعليمية شاملة بوسائل تدريس ملائمة.
- رفع الوعي المجتمعي حول الإعاقة السمعية وتعزيز فهم المجتمع لها.
- تقديم الدعم النفسي لمساعدة الأفراد على التكيف مع التحديات.

أهداف التعامل مع الإعاقة السمعية

1) الأهداف التعليمية

- تحسين القدرات اللغوية والتواصلية من خلال تعليم لغة الإشارة أو تقنيات التواصل اللفظي.
- توفير بيئة تعليمية ملائمة تضم أجهزة سمعية ومعلمين مدربين.
- دمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في المدارس العادية أو توفير مدارس متخصصة تناسب احتياجاتهم .

2) الأهداف التأهيلية والطبية

- استخدام الأجهزة التعويضية مثل السماعات الطبية وزراعة القوقعة لتحسين القدرة السمعية.
- تطوير مهارات النطق والتخاطب من خلال برامج علاجية متخصصة.
- تقديم دعم نفسي وتأهيلي لمساعدتهم على التكيف مع إعاقتهم.

3) الأهداف الاجتماعية والدمج المجتمعي

- تعزيز اندماجهم في المجتمع عبر توفير فرص عمل مناسبة.
- نشر الوعي حول الإعاقة السمعية للحد من التمييز وتعزيز تقبل المجتمع لهم.
- تشجيع المشاركة في الأنشطة الثقافية، الرياضية، والفنية.

4) الأهداف القانونية والحقوقية

- ضمان حقوقهم في التعليم، الرعاية الصحية، والعمل.
- تعزيز استخدام لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تواصل فعال.

- دعم القوانين التي تحميهم من التمييز وتكفل حقوقهم.

5) أهداف عامة

- التعرف على مفهوم الإعاقة السمعية وأسبابها وأنواعها.
- دراسة الإحصائيات المرتبطة بهذه الفئة محليًا وعالميًا.
- تسليط الضوء على حقوقهم وفقًا للمواثيق الدولية.
- استكشاف دور المؤسسات في دعم ذوي الإعاقة السمعية.
- تحليل تأثير الإعاقة السمعية على جودة الحياة والرفاهية.

6) أهداف تعليمية

- بحث التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في التعليم.
- تقييم فعالية البرامج التعليمية المخصصة لهم.
- استعراض طرق التدريس الملائمة، مثل التعليم المدمج ولغة الإشارة.
- دراسة تأثير زراعة القوقعة على الأداء الأكاديمي للأطفال.
- تحليل دور المعلمين في تحسين تجربة التعلم.

7) أهداف اجتماعية ونفسية

- تحليل تأثير الإعاقة السمعية على التفاعل الاجتماعي والعلاقات الأسرية.
- دراسة معدلات القلق والاكتئاب لديهم مقارنة بغيرهم.
- تقييم مدى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
- تحليل دور الأسرة في دعم الأفراد ذوي الإعاقة السمعية.
- استكشاف أثر التقبل الاجتماعي على صحتهم النفسية.

8) أهداف تكنولوجية وتأهيلية

- دراسة أحدث التقنيات المساعدة، مثل الأجهزة السمعية والتطبيقات الذكية.
- تقييم فاعلية زراعة القوقعة مقارنة بالأجهزة السمعية التقليدية.
- استعراض أهمية الترجمة الفورية بلغة الإشارة في تسهيل التواصل.

خصائص الإعاقة السمعية

- الإعاقة السمعية تؤثر على عدة جوانب من حياة الفرد، بما في ذلك التواصل، التعلم، النمو النفسي والاجتماعي، والجوانب الحركية. وفيما يلي تفصيل لأبرز خصائص هذه الإعاقة:

1. الخصائص اللغوية

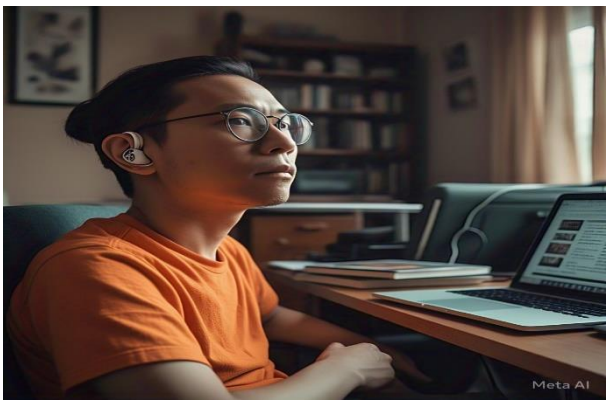
- تأخر في اكتساب اللغة، خاصة إذا حدثت الإعاقة قبل تعلم الكلام.
- ضعف في مخزون الكلمات وصعوبة في تشكيل الجمل مقارنة بالأشخاص ذوي السمع الطبيعي.
- تأثر نطق الأصوات والكلمات، مع بطء في الكلام أو اختلاف في نبرته.
- الاعتماد على لغة الإشارة أو قراءة الشفاه كوسائل تواصل بديلة.
- صعوبة في فهم المحادثات، خاصة في البيئات الصاخبة.
- العلاقة طردية بين شدة الإعاقة اللغوية ودرجة فقدان السمع، فكلما زادت الإعاقة السمعية زادت المشكلات اللغوية.

2. الخصائص المعرفية

- هناك خلاف بين الباحثين حول تأثير الإعاقة السمعية على الذكاء، لكن من المتفق عليه أن تأثر اللغة قد يؤثر على الفهم والاستيعاب.
- يواجه الأفراد ذوو الإعاقة السمعية تحديات في تعلم المفاهيم المرتبطة باللغة، بينما لا تتأثر المفاهيم غير اللفظية بنفس الدرجة.
- الفرق الزمني في التعلم: ما يتعلمه الطفل السامع في ساعة قد يحتاج الطفل المعاق سمعياً إلى ضعف المدة لتعلمه.
- غالبًا ما تكون اختبارات الذكاء التقليدية غير دقيقة لقياس قدرات المعاقين سمعياً بسبب تركيزها على اللغة اللفظية.

3. الخصائص الاجتماعية والنفسية

- يعاني العديد من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية من صعوبة في التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والانسحاب الاجتماعي.



- قد يظهر عليهم الخجل أو التردد عند التعامل مع الآخرين بسبب الخوف من سوء الفهم.
- ضعف في القدرة على فهم تعابير الوجه ولغة الجسد لدى الآخرين، مما يؤدي إلى سوء تفسير المواقف.
- قد يعانون من القلق والاكتئاب نتيجة لعدم اندماجهم الكامل في المجتمع.
- مفهوم الذات لديهم قد يكون غير دقيق؛ فالبعض يعاني من تدني الثقة بالنفس، بينما قد يكون لدى آخرين تصورات مبالغ فيها عن قدراتهم.
- الأطفال الذين ينتمون إلى أسر يعاني أحد أفرادها من الإعاقة السمعية يكون لديهم تكيف اجتماعي أفضل مقارنة بمن ينتمون إلى أسر من ذوي السمع الطبيعي.

4. الخصائص الأكاديمية

- التحصيل الدراسي للأفراد ذوي الإعاقة السمعية غالبًا ما يكون أقل مقارنة بأقرانهم، خاصة في المواد التي تعتمد على الفهم اللغوي مثل القراءة والكتابة.
- التأخر في القراءة يعد من أبرز المشكلات الأكاديمية لديهم، حيث قد يكون مستوى القراءة لديهم في سن العشرين مماثلًا لمستوى طلاب في الصف الرابع أو الثامن.
- العلاقة طردية بين مستوى التعقيد اللغوي في المناهج الدراسية ومستوى التحصيل الأكاديمي لديهم، حيث تؤثر المتطلبات اللغوية على استيعابهم للمعلومات.
- الحاجة إلى أساليب تدريس بديلة تعتمد على الوسائل البصرية والتقنيات السمعية المساعدة.

5. الخصائص الحركية والجسمية

- لا تؤثر الإعاقة السمعية بشكل مباشر على النمو الجسدي، ولكن بعض الأفراد قد يعانون من مشكلات في التوازن نظرًا لارتباط جهاز التوازن بالأذن الداخلية.
- بعض الأفراد قد يطورون أوضاعًا جسمية غير صحيحة نتيجة لعدم تلقي التغذية الراجعة السمعية لحركاتهم.

- التأخر الحركي مقارنة بالأفراد العاديين بسبب قلة تفاعلهم مع بيئتهم المحيطة.
- بعض الأشخاص المعاقين سمعياً يمشون بطريقة مميزة، حيث لا يرفعون أقدامهم عن الأرض بالكامل، وذلك لشعورهم بالأمان عند بقاء أقدامهم على الأرض.

عيوب الإعاقة السمعية وتأثيرها على التواصل والتعلم

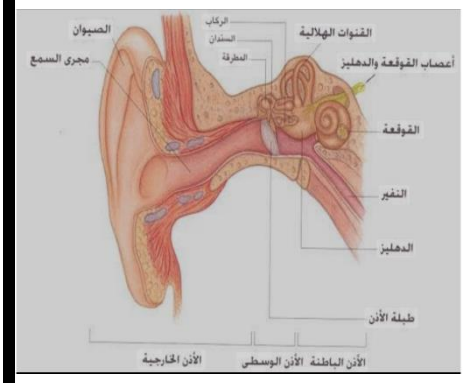
- صعوبة في فهم الكلام، خاصة في الأماكن المزدحمة أو عند التحدث مع أشخاص غير معتادين على التواصل معهم.
- صعوبة في التعبير عن الأفكار، مما قد يؤدي إلى الإحباط أو العزلة الاجتماعية.
- مشكلات في القراءة والكتابة نتيجة لضعف المهارات اللغوية وتراكم الفجوات في التعلم.
- الحاجة إلى استراتيجيات تعليمية بديلة مثل استخدام الوسائل البصرية والمترجمين بلغة الإشارة أو الأجهزة السمعية المساعدة.

الخلاصة

- الإعاقة السمعية تؤثر على مختلف جوانب حياة الفرد، بدءًا من اللغة والتواصل، مرورًا بالجوانب النفسية والاجتماعية، ووصولًا إلى الأداء الأكاديمي والتفاعل مع البيئة.
- ومع ذلك، فإن توفير الدعم المناسب، مثل التعليم المكيف، والأجهزة المساعدة، والتوعية الاجتماعية، يمكن أن يساعد الأفراد ذوي الإعاقة السمعية على تحقيق استقلاليتهم والاندماج بشكل فعال في المجتمع.

يبدو أن هناك تكرارًا في بعض الفقرات، وسأقوم بإعادة تنظيمها وتنسيقها بطريقة أكثر وضوحًا دون تغيير أي كلمة أو حرف:

العيوب في الصحة النفسية والاجتماعية

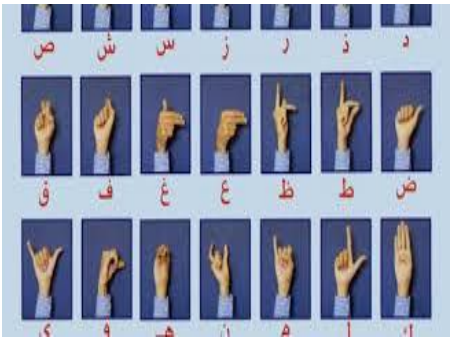


- التوتر والقلق :يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية أكثر عرضة للتوتر والقلق.
- الاكتئاب :يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية أكثر عرضة للاكتئاب.
- صعوبة في بناء العلاقات :يواجهون صعوبة في بناء العلاقات مع الآخرين.

1) العيوب في الحياة اليومية

- صعوبة في استخدام الهاتف :يواجهون صعوبة في استخدام الهاتف، خاصة إذا كانوا لا يفهمون لغة الإشارة.
- صعوبة في مشاهدة التلفزيون :يواجهون صعوبة في مشاهدة التلفزيون، خاصة إذا كانوا لا يفهمون لغة الإشارة.
- صعوبة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية :يواجهون صعوبة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، خاصة إذا كانوا لا يفهمون لغة الإشارة.

2) العيوب في التواصل والتعلم



- صعوبة في فهم الكلام :يواجهون صعوبة في فهم الكلام، خاصة في البيئات الصاخبة.
- صعوبة في التعبير عن أنفسهم :يواجهون صعوبة في التعبير عن أنفسهم، خاصة إذا كانوا لا يفهمون لغة الإشارة.
- صعوبة في القراءة والكتابة :يواجهون صعوبة في القراءة والكتابة، خاصة إذا كانوا لا يفهمون لغة الإشارة .

كيفية تشخيص الإعاقة السمعية

- يعتمد تشخيص الإعاقة السمعية على مجموعة من الاختبارات الطبية والتقييمات التي يحددها الطبيب المختص (أخصائي الأنف والأذن والحنجرة أو أخصائي السمعيات). ومن أهم هذه الطرق:

الفحص السريري والتاريخ الطبي

- يسأل الطبيب عن الأعراض وتاريخ فقدان السمع، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والتعرض للضوضاء أو الإصابات.
- يفحص الأذن للكشف عن التهابات أو انسدادات قد تؤثر على السمع.

اختبارات السمع

- اختبار الشوكة الرنانة :يحدد نوع فقدان السمع (توصيلي أم حسي عصبي).
- مخطط السمع :يقيس قدرة الشخص على سماع نغمات ذات ترددات مختلفة.

- قياس استجابة جذع الدماغ السمعية :يستخدم للكشف عن مشكلات العصب السمعي والمخ.
- قياس انبعاثات الأذن الداخلية :يختبر استجابة القوقعة للأصوات، ويستخدم غالبًا لفحص حديثي الولادة.

اختبارات السمع للأطفال والرضع

- اختبار السمع بالسلوك :يقيس استجابة الطفل للأصوات باستخدام الألعاب أو الأضواء.
- الاستجابة السمعية المحرضة للدماغ والانبعاثات الصوتية القوقعية :غالبًا ما يستخدمان لفحص حديثي الولادة.

اختبارات الكلام والفهم

- اختبار تمييز الكلام :يقيس قدرة الشخص على سماع الكلمات وتمييزها.

اختبارات التصوير الطبي

- التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية :تستخدم في حالات الاشتباه بوجود ورم أو تشوه في الأذن الداخلية أو العصب السمعي.
- بهذه الطرق، يتمكن الأطباء من تحديد طبيعة الإعاقة السمعية ودرجتها، مما يساعد في وضع خطة علاج مناسبة.

البرامج المستخدمة في الإعاقة السمعية

- تهدف البرامج المخصصة للأفراد ذوي الإعاقة السمعية إلى تسهيل التواصل والتعلم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. ومن أبرز هذه البرامج:

برامج الترجمة النصية

- تساعد في تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، مما يسهل على الأشخاص الصم أو ضعاف السمع متابعة المحادثات والحوارات. مثل:
- Dragon NaturallySpeaking
- Live Transcribe

برامج التدريب على قراءة الشفاه

- تساعد الأفراد الصم على تحسين مهاراتهم في قراءة الشفاه لفهم ما يقوله الآخرون، وهناك تطبيقات وبرامج تعليمية متخصصة في هذا المجال.

برامج لغة الإشارة

- توفر بعض التطبيقات والبرامج دروسًا في تعلم لغة الإشارة، مثل:
- SignSchool
- ASL App

برامج تقوية السمع

- تُستخدم بعض البرامج بالتزامن مع الأجهزة المساعدة مثل السماعات الطبية، حيث تساعد في تحسين وضوح الصوت وتحليل الأصوات بشكل أفضل، مثل:
- برامج المساعدة في السمع المدمجة مع الأجهزة القابلة للارتداء .

البرامج التعليمية التكيفية

- تستهدف هذه البرامج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مختلف المراحل التعليمية، وتُستخدم عادةً في المدارس لتقديم دروس تعليمية مخصصة حسب احتياجاتهم.

برامج الاستماع عبر الإنترنت

- تقدم بعض المواقع والتطبيقات دروسًا صوتية مع نصوص توضيحية للمساعدة في التواصل مع الأشخاص الصم، مثل:
- Zoomالذي يدعم الترجمة النصية المباشرة.

الخاتمة

- تُعد الإعاقة السمعية تحديًا يواجهه الإنسان، لكنها لا تعني نهاية الطموح أو توقف مسيرة النجاح، بل على العكس، هي بداية لقصة كفاح وإصرار تتجلى فيها قدرة الإنسان على التكيف والتأقلم مع ظروفه.
- يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية إلى الفرص المناسبة لإظهار إمكانياتهم، فمن المهم فهم احتياجاتهم وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها. كما أن تعزيز

الوعي المجتمعي حول الإعاقة السمعية يُعدّ خطوة أساسية نحو دمجهم في مختلف جوانب الحياة، من خلال نشر ثقافة الاحترام والتقبل، وتوفير وسائل التواصل المناسبة، مثل لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة.

- التعليم الدامج هو أحد الركائز الأساسية لدعم ذوي الإعاقة السمعية، حيث يراعي الفروق الفردية ويوفر الأدوات التي تساعدهم في تحقيق النجاح. كما أن الدعم النفسي والمعنوي له دور كبير، إذ يحتاج هؤلاء الأفراد إلى الشعور بأنهم مقبولون ومحبوبون في المجتمع، ولديهم القدرة على المشاركة الفاعلة وتحقيق طموحاتهم.
- دور الأسرة محوري في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فالدعم الأسري يشكل الأساس في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المواهب والقدرات. كما أن التعاون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ضروري لتقديم الرعاية الشاملة والمناسبة.
- التكنولوجيا الحديثة تُعتبر أداة قوية في تحسين حياة ذوي الإعاقة السمعية، حيث ساعدت أجهزة السمع، وزراعة القوقعة، وتطبيقات الترجمة الفورية، وبرامج التعلم التفاعلية في تحسين جودة الحياة بشكل كبير. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يزداد الأمل في توفير حلول أكثر تقدمًا تساعد هذه الفئة على تجاوز العوائق التي تواجهها.